

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	腦中風 Cerebrovascular Accident；CVA				
編號	A31000-Q03-W-A01	制定者	R14 李嘉綺	公布日期	97 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 01 月 06 日
版本/總頁數	第 4.2 版/14 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 01 月 06 日

一、目的

讓護理人員了解腦中風的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

腦中風乃指一種突發地產生局部暫時性或永久性神經學障礙的徵狀。使得腦部任一區域供給之血管非常突然、快速地發生損傷障礙或病變，導致腦部循環中斷或氧氣供應不足導致腦部神經受損。

（二）症狀

1. 特定腦血管受阻導致中風之臨床表徵。

病因	位置	可能症狀與徵候
梗塞	頸動脈	半身不遂或半身偏癱、失語症、頭痛、神智障礙、半身麻木或半身感覺遲鈍、意識不清、單側癱瘓或單側輕癱、視力障礙、肢體感覺異常、抽搐、同側視野缺失、視神經萎縮、同側視野喪失合併對側偏癱。
	前椎動脈、脊椎和椎體上部之動脈	兩腳或四肢無力或麻木、轉頭或扭頸時發生無力或昏眩、起立困難、發音和吞嚥困難、單側或雙側痛覺遲鈍。
	後下和前下小動脈、上小腦動脈	起立困難、共濟不能。
梗塞	內聽動脈、耳迷路、耳蝸動脈	昏眩、噁心、嘔吐、耳鳴。
	基底動脈	頭痛和昏厥、木僵或昏迷、複視、眼動神經麻痺、單側或雙側痛覺遲

主題名稱	腦中風	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A01	版本	第 4.2 版	頁碼/總頁數	2/14

病因	位置	可能症狀與徵候
	*中腦 *橋腦	鈍、陣發性高血壓。
	視丘	痛性麻木或自發性疼痛、震顫。
	下視丘	舞蹈症。
	中大腦動脈 *主幹 *上分枝 *下分枝 *穿動脈	半身麻痺、半身無感覺、半盲、失語症、半身無力與感覺喪失（上肢及臉較嚴重）、運動性失語症、感覺性失語症、空間感覺喪失、純運動性半身無力。
	前大腦動脈	半身無力與感覺缺失（下肢較嚴重）、尿失禁、步態失用（運用不能）症、運用不能性失語症。
	後大腦動脈 *單側皮質 *優勢位 *非優勢位 *雙側皮質 *雙側下顳葉	對側性偏盲、失讀症、失名症、局部定向感障礙、顏面失認症、皮質性全盲、失憶症。
出血	基底核	對側半身無力、感覺喪失及同側半盲、失語症（位於優勢半球）、眼睛偏下側或朝向血腫側（麻痺之對側）、意識不清、木僵或昏迷。
	小腦	嘔吐及運動失調、眼球歪斜與瞳孔縮小、眼球偏向疾病之對側、反應遲鈍、晚期會木僵或昏迷。
	橋腦	突發性昏迷、對光有反應如針尖般瞳孔、眼球歪斜及凝視麻痺、去大腦性姿勢或遲緩性麻痺、失調性呼吸。

2. 左右側中風之特徵

右側腦受損	左側腦受損
左側偏癱	右側偏癱
空間與認知缺損	語言障礙（若左腦為優勢側）
行為型態改變（快、衝動）	行為型態改變（慢、小心）
記憶力喪失（表現方面）	記憶力喪失（語言方面）
表情淡漠，不在意殘障	由於殘障造成心理抑鬱、痛苦
左側視野喪失	右側視野喪失
注意力短暫	語言及計算能力降低
無法辨認臉孔	左右辨認不清
對精巧事物欣賞力降低	

主題名稱	腦中風	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A01	版本	第 4.2 版	頁碼/總頁數	3/14

(三) 常見檢查

1. 急性期之常見檢查：

- (1) 腦部電腦斷層攝影檢查(computerized tomography, CT)。
- (2) 腦部核磁共振造影檢查(magnetic resonance imaging, MRI)。
- (3) 腦電波檢查(electroencephalogram, EEG)。
- (4) 血管攝影(angiography)。
- (5) 心電圖(electrocardiogram)。
- (6) 頸動脈超音波攝影檢查。
- (7) 頸動脈血管攝影檢查。
- (8) 心臟超音波攝影檢查(cardio echo)。

2. 復健期之常見檢查：

- (1) 腦部電腦斷層攝影檢查(computerized tomography, CT)。
- (2) 腦電波檢查(electroencephalogram, EEG)。
- (3) 心臟超音波攝影檢查(cardio echo)。
- (4) 吞嚥攝影。
- (5) 睡眠檢查。

(四) 常見治療

1. 藥物治療：(1)血栓溶解劑(2)抗血栓藥物(3)降低顱內壓藥物(4)抗癲癇藥物(5)降血壓藥物(6)神經肌肉鬆弛劑等。

2. 常見復健介入項目

- (1) 物理治療：運動治療、促進技術、伸展治療。
- (2) 職能治療：姿勢訓練、被動性運動、平衡訓練、痙攣性復位運動。
- (3) 語言治療：聽覺的理解力訓練、觸覺的刺激、口腔治療、吞嚥訓練。
- (4) 心理治療智商測驗、職業性向、心理治療等。
- (5) 睡眠障礙治療。
- (6) 輔具的選擇。

主題名稱	腦中風	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A01	版本	第 4.2 版	頁碼/總頁數	4/14

(五) 護理問題

- 1.身體活動能力異常／神經肌肉障礙。
- 2.吞嚥功能障礙／神經肌肉障礙。
- 3.語言溝通困難／疾病造成大腦皮質障礙、身體障礙：氣管造口術或氣管插管。
- 4.易跌倒／神經肌肉障礙。
- 5.自我照顧尋求協助：穿著及修飾／活動無耐力。
- 6.自我照顧尋求協助：進食／神經肌肉障礙。
- 7.自我照顧尋求協助：如廁／與身體活動功能障礙有關。
- 8.呼吸道清除功能不良／濃稠分泌物。
- 9.排便異常／體能活動量不足。
- 10.照顧者感到緊張／照顧者之健康狀態變差。

(六) 護理措施

- 1.身體活動能力異常／神經肌肉障礙。
 - (1) 監測患肢 6P signs (pain 疼痛、paresthesia 感覺異常、paralysis 麻痺、pallor 蒼白、pulslessness 無脈搏、poikilothermia 溫度改變)，並評估身體活動功能障礙程度。
 - (2) 建議漸進式活動，教導並示範移動技巧。
 - (3) 示範增加活動力的方法及 ROM 等長運動、等張運動。
 - (4) 教導活動時注意之安全措施。
 - (5) 協助並教導正確使用輔助器。
 - (6) 活動後抬高患肢促進末梢之血循，減輕腫脹。
 - (7) 使用副木或輔具時，保持接觸面的皮膚完整性並避免受壓迫。
 - (8) 依醫囑予骨骼肌鬆弛劑。
 - (9) 依醫囑使用固定器或夾板固定關節不動，可減輕疼痛，並避免無功能姿勢的攣縮。
 - (10) 提供急性患肢關節休息和支托，以穩定、降低關節壓力及增加肌肉鬆弛。

主題名稱	腦中風	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A01	版本	第 4.2 版	頁碼/總頁數	5/14

(11)向病人或家屬解釋關節及肌肉運動的重要性。

(12)平衡休息治療與主動身體運動計劃以增進體力及功能。

(13)評值病人身體活動功能活動後反應。

2.吞嚥功能障礙／神經肌肉障礙。

(1) 確認病人和家屬了解病因。

(2) 觀察吞嚥困難引起之合併症，如咳嗽、吸入異常。

(3) 教導病人和家屬照顧技巧並評估完成情形。

(4) 觀察病人和家屬之學習照顧的行為。

(5) 鼓勵練習吞嚥動作。

(6) 觀察病人吞嚥行為和評值問題。

(7) 應用吞嚥障礙規範執行和紀錄評估。

(8) 指導減輕引起吞嚥困難之方法及措施。例如：插 NG-Tube。

(9) 假如需要應教導病人照顧措施。

3.語言溝通困難／疾病造成大腦皮質障礙、身體障礙：氣管造口術或氣管插管。。

(1) 評估病人意識狀態、語言文化、教育程度及肢體動作所表達意義。

(2) 評估並找出雙方可溝通方式（語言、非語言等）。

(3) 教導並提供數種表達需要的方式，如筆或簡易圖片來進行溝通。

(4) 教導以問答方式，必要時可加上肢體動作來達成有效溝通。

(5) 剛開始問病人問題時，應選擇答案簡單、只有幾個字之問題。

(6) 每次示範並支持有效雙向溝通的重要性。

(7) 適當給予鼓勵及讚美以增加病人自尊及信心。

(8) 提供病人練習有效溝通技巧之機會。

(9) 示範及鼓勵以非語言行為代替或加強語言上之表達。

(10)在溝通過程中，應鼓勵及教導使用正確適當的方法來表達生氣及挫折。

(11)每次護理前後予再解釋，並確定瞭解治療的原因及目的。

(12)必要時請家屬（或朋友）來加以翻譯，達成適當溝通。

主題名稱	腦中風	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A01	版本	第 4.2 版	頁碼/總頁數	6/14

(13)每次溝通前後注意病人反應及表情、潛在含意。

(14)每班記錄和病人溝通的狀況並評值其與護理活動互動情形。

(15)當護理人員無法瞭解病人意思時，應給予適當無條件正向鼓勵及讚美，以增加引導，並安撫之。

4.易跌倒／神經肌肉障礙。

(1) 病人臥床時使用床欄並注意床欄穩固。

(2) 降低病床高度。

(3) 使用夜燈的設置。

(4) 防滑墊、止滑鞋的穿著。

(5) 清除病床到浴室間的障礙物，保持地面乾燥及適當照明。

(6) 護理人員每班至少兩小時查看病人情形。

(7) 將尿壺或便盆置於可拿取位置且倒空。

(8) 讓病人及家屬瞭解目前之行動能力及限制，應採漸進式行動，且有人在旁扶助。

(9) 教導病人使用叫人鈴（紅燈）並置於適當位置。

(10)讓病人及家屬瞭解正在服用易導致跌倒的藥物，如降血壓及安眠藥等。

(11)衛教病人在服用藥物後半小時內改變姿勢宜緩慢。

(12)必要時依醫囑給予適當的約束。

(13)依照顧者國籍給予預防跌倒照護單張。

5.自我照顧尋求協助：穿著及修飾／活動無耐力。

(1) 與病人一同監測和討論情境的變化、能做哪些修飾及如何執行。

(2) 與病人一起做護理計劃和確認結論，以增加病人對情境的控制感。

(3) 鼓勵做可強化弱肢的運動，增進其平衡感與靈敏度。

(4) 視需要提供教學、督導與協助。

(5) 給予病人讚美與鼓勵做為強化與回饋。

(6) 提供有簡單綁繫的寬鬆衣服，並給予充分的時間以穿戴完整。

主題名稱	腦中風	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A01	版本	第 4.2 版	頁碼/總頁數	7/14

(7) 評估危險性，並且採取預防措施，將危險減至最低。

(8) 督促病人穿著及修飾活動（梳髮、化妝、刮鬍子），並視需要提供協助，以確保病人能做得令人滿意，並使外觀顯得整潔乾淨。

(9) 增加支持來源的層次，減少病人進一步失能的速率，並且維持病人的參與。

6.自我照顧尋求協助：進食／神經肌肉障礙。

(1) 與病人討論情況的變化，並且告訴其任何有關治療的預期效果，以增加對照顧者的信賴。

(2) 與病人一起做護理計劃和確認結論，以增加病人對情境的控制感。

(3) 在訂定措施時，應考慮病人的認知或知覺功能不良、口腔運動障礙或手臂與手的控制力不佳；協助病人選擇輔助器皿、選擇與準備食物和飲料，以促進其獨立性與安全性。

(4) 視需要提供教學、督導與協助。

(5) 給予病人讚美與鼓勵做為強化與回饋。

(6) 監督每餐的進食活動，以確定其進展程度。

(7) 病人或家屬一同確認其對食物的偏好、所偏好的進食時間、地點與共同進餐者，儘可能提供病人習慣的方式。

7.自我照顧尋求協助：如廁／與身體活動功能障礙有關。

(1) 監督病人如廁活動，並且視需要提供督導與協助，以確定其進展程度。

(2) 當病人能獨立執行如廁活動時，給予支持與鼓勵。

(3) 確認病人的排尿與排便型態，並協助建立排尿與排便計劃；當病人求協助時立即回應，協助其達到控制與避免失禁發生。

(4) 當病人如廁時，提供其隱密性。

(5) 對病人失禁的現象不加以評論，以避免造成病人困窘及強忍如廁的需要。

(6) 將呼叫鈴置於病人伸手可及之處，避免發生跌倒。

(7) 視需要協助病人清潔，重整衣物，確保乾淨舒適和整潔的外觀。

8.呼吸道清除功能不良／濃稠分泌物。

主題名稱	腦中風	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A01	版本	第 4.2 版	頁碼/總頁數	8/14

- (1) 評估呼吸狀況，記錄呼吸頻率和節律、呼吸音、咳嗽和分泌物的特性。
- (2) 監測脈搏血氧定量法和動脈血液氣體分析值。
- (3) 依醫囑送檢體做培養、細胞學和敏感試驗。
- (4) 協助病人採高坐臥姿至少每 2 小時翻身一次以移動分泌物。
- (5) 教導病人深呼吸後有效咳嗽。
- (6) 必要時，抽吸呼吸道，抽吸時間以 10 秒為限。
- (7) 抽吸前後，先給予氧氣或鼓勵深呼吸，使肺過度充氣。
- (8) 依醫囑執行胸部物理治療，例如叩擊、姿位引流。
- (9) 提供病人足夠氧合狀態：鼓勵經口攝取液體或依醫囑維持靜脈輸液。
- (10) 依醫囑給予濕潤的氧氣，尤其當病人身上有人工氣管時。
- (11) 依醫囑給予藥物，例如支氣管擴張劑、類固醇、祛痰劑和抗生素。
- (12) 記錄護理措施的效果。

9. 排便異常／體能活動量不足。

- (1) 應用大便訓練規範執行並記錄評估。
- (2) 教導病人及家屬大便訓練過程並確認皆已瞭解。
- (3) 於經濟許可內，修改飲食內容，增加高纖維食物的比例，如：每天吃含麥麩的食品每天吃一份高纖維蔬菜以全麥麵包取代白麵包每天攝取棗子、香蕉或喜愛的新鮮果汁。
- (4) 教導病人記錄 24 小時所有攝取飲食的內容。
- (5) 與病人及家屬分析飲食型態。
- (6) 教導肢體關節活動，最好每天進行兩次主動性全關節活動。
- (7) 每天作腹肌運動。

10. 照顧者感到緊張／照顧者之健康狀態變差。

- (1) 擬定計畫以監測照顧者的健康狀況。
- (2) 教導維持每日活動及休息、睡眠時間的平衡。
- (3) 協助病人或照顧者於照顧者生病時，改變照顧計畫。

主題名稱	腦中風	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A01	版本	第 4.2 版	頁碼/總頁數	9/14

- (4) 監測照顧者之抑鬱及壓力程度。
- (5) 引導照顧者說出內心感受並以同理心傾聽之。
- (6) 評估目前家庭支持系統，若需要則協助安排合適之轉介。
- (7) 教導時間處理及利用方法。

(七) 部份內容參考復健科病房各項衛教單張。

1. 壓力性損傷的預防

- (1) 減少對組織的壓力。
- (2) 每 2 小時為病人翻身。
- (3) 讓病人採適當的臥位。
- (4) 利用枕頭或其他工具支托身體。
- (5) 避免摩擦力、剪力。
- (6) 保持床單的平整。
- (7) 搖高床尾或墊枕頭在膝窩，以防病人向下滑。
- (8) 增強及保護病人的皮膚。
- (9) 為病人操作或協助做關節運動。
- (10) 注意營養及水份的供給。

2. 半身偏癱病人穿脫衣褲的方法

- (1) 穿脫衣服→脫衣時：由健側先脫掉，再脫患側。穿衣時：由患側先穿，再穿健側。
- (2) 穿脫褲子→方法同穿脫衣服。

3. 中風病人坐起及移位技巧

- (1) 坐起：病人以健腳置於患腳下，將患腳勾動帶至床緣外，身體側臥向健側→以健側手臂用力，逐漸將身體撐起→坐在床緣，以健手支撐平衡。
- (2) 移位：病人坐在床邊，以健手握住椅子扶手，站起來→病人站穩後將健手移至椅子的另一扶手→將健腳向後方移動一步，並轉身→以健側手腳做重心，慢慢坐下。

主題名稱	腦中風	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A01	版本	第 4.2 版	頁碼/總頁數	10/14

4.腦中風的預防

- (1) 減少危險因子：如戒菸，控制高血壓、糖尿病、血脂肪、膽固醇為宜。
- (2) 按醫囑服藥：如服用抗血小板製劑。
- (3) 控制體重：三少一多（鹽少、糖少、油少、水多）。
- (4) 規律的復健運動及正常生活起居。
- (5) 控制並減少短暫性腦血管缺血發作。
- (6) 重視腦中風的先兆徵象：如頭暈、頭痛、肢體麻木、嗜睡、性格反常等。
- (7) 消除中風的誘發因素：如情緒波動、過度疲勞、用力過猛等，應自我控制及避免。
- (8) 注意心理預防：保持精神愉快及情緒穩定。

（八）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

五、流程圖

（略）

六、參考資料

- （一）陳嘉玲、王昱菱(2020)．腦中風之復健，於賴金鑫、畢柳鶯、王亭貴總編輯，復健及物理醫學-臨床篇（第二版，3-32 頁）．合記。
- （二）倪麗芬(2018)．神經系統疾病復健護理，於陳妙言總校閱，復健護理學（一版，322-334 頁）．華杏。
- （三）馮容芬(2020)．腦血管疾病與護理，於劉雪娥總校閱，成人內外科護理（八版，125-146 頁）．華杏。

主題名稱	腦中風	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A01	版本	第 4.2 版	頁碼/總頁數	11/14

(四) Linda L. P.(2021)·最新護理診斷手冊:護理計畫與措施(郭惠敏、黃靜微、張秉宜、程子雲、胡慧蘭、林家綾、喬佳宜、林麗秋譯;4版)·華杏。

七、附件

(略)

主題名稱	腦中風	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A01	版本	第 4.2 版	頁碼/總頁數	12/14

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
97.05.31	1.0	新制定。	97 年 05 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.08.31	2.1	1. 修改說明內容。 2. 修改錯別字與英文拼音。	100 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
101.08.31	2.2	1. 醫護部改護理部。 2. 護理措施修改部份內容。	101 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.08.31	3.1	說明內容部份修辭。	102 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.08.31	3.2	參考資料內容部份更新。	103 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
104.08.31	3.3	第六項參考資料文獻部份內容更新。	104 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
105.08.31	3.4	1. 參考文獻新增於內文。 2. 第三項第(七)目之 4 腦中風的預防內容更新。 3. 第三項第(四)目之 2 容部份修訂。 4. 第六項參考資料增刪及修訂。	105 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
106.08.31	3.5	1. 第三項第(六)目新增 6P signs 內容。 2. 第六項參考資料增刪及修訂。	106 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
107.06.29	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	3.6	第二項新增（含中興分院）。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過。

主題名稱	腦中風	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A01	版本	第 4.2 版	頁碼/總頁數	13/14

修正日期	版本	修正說明	備註
108.05.15	3.7	1. 第三項第八目之 1 壓瘡更改為壓力性損傷。 2. 第三項第九日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 05 月 15 日照護標準組會議通過；108 年 05 月 20 日督導會議通過公布。
109.08.06	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.10.19	3.8	1. 第三項第一目定義說明內容修訂。 2. 第三項說明內容 APA 格式修訂。 3. 第六項參考資料修訂。	110 年 10 月 07 日照護標準組會議通過；110 年 10 月 13 日護理長會議通過；110 年 10 月 19 日督導會議通過公布。
111.11.08	3.9	1. 第三項第五目、第六目修訂護理診斷。 2. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過；111 年 10 月 12 日護理長會議通過；111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.11.21	4.0	第三項第五目、第六目修訂護理問題。	112 年 10 月 26 日照護標準組會議通過；112 年 11 月 08 日護理長會議通過；112 年 11 月 21 日督導會議通過公布。
113.12.17	4.1	第三項第五目、第六目修訂護理問題。	113 年 10 月 15 日照護標準組會議通過；113 年 12 月 11 日護理長會議通過；113 年 12 月 17 日督導會議通過公布。
115.01.06	4.2	第三項第四目修訂藥物治療。	114 年 10 月 02 日照護標準組會議通過；114 年 12 月 10 日護理長會議通過；115 年 01 月 06 日督導會議通過公布。

主題名稱	腦中風	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A01	版本	第 4.2 版	頁碼/總頁數	14/14

修正日期	版本	修正說明	備註